

RICARDO FRATTINI SANAIOTTE

HD:

APNEIA DO SONO

MEDICO:

MEDICAMENTOS:

IMC

CIRCUNF. DE PESCOÇO

PA:

OXIMETRIA:

14/05 P=9 cmH₂O

21 IAH=4.6 l/min

Oriento ajuste

m. de uso: 6h 33'

Fuga de ar 25,6 $\Delta\Delta$ - fua

27/05

P=9.0

m. de uso: 6h 40'

IAH=9.4

Fuga 33,4

fua

30/06

P=9.0

Δ P1 P=9.5

IAH=4.0 - AC=1.6/lv

21

Fuga=11.2

Oriento o uso contínuo do CPAP - fua.

TROCO o filtro

10/09

P=9.0

21

IAH=2.9/lv

m. de uso: 6h 43'

Fuga=1.1

fua claudia

16/11

P=9.0

11

IAH=0.0

21

m. de uso: 6hr.

Fuga=1.5

fua

19/01

P=9.0 cmH₂O

22

IAH=2.3/lv

Fuga=2.3

m. de uso: 6h 20'

S/ exercício

fua

16/03

P=9.0 cmH₂O

22

IAH=3.1

m. de uso: 5h 51'

com exerc. físico

fua.

17/05

22

P=9.0

IAH=3.4

M. de uso: 4h 30'

Bem adaptado, porém q pouco uso.

* másc. nasal
alinhada

fua

18/07
22

$P = 9.8 \text{ cmH}_2\text{O}$ -
 $IAH = 4.1 \text{ /ev}$
M. de uso: 5h43'
Bem adaptado, porém manutenção do sono
está ruim. *fuca*

18/08
22

$P = 9.0 \text{ cmH}_2\text{O}$ -
 $IAH = 3.6 \text{ /ev}$
M. de uso: 5h40'
Relata: que alguns dias dorme na sala.
Solicito uso 4 e 4 n° *fuca*

17/10
22

$P = 9.0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 3.0 \text{ /ev}$
M. de uso: 5h.
Bem adaptado, oriento sobre o uso. *fuca*

22/11
22

$P = 9.0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 4.3 \text{ /ev}$
Fuga: 4.7 e/ev
Está utilizando em dias alternados. — *fuca*

19/01
23

$P = 9 \text{ cmH}_2\text{O}$
M. de uso: 4h45 e/min
 $IAH = 3.3 \text{ e/h}$
Bem adaptado, porém não está
utilizando a noite toda — *fuca*

16/03
23

$P = 9 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 4.6 \text{ e/h}$
Fuga = 0.0 e/min.
M. de uso: 4h26' *fuca*

19/04
23

$P = 9 \text{ cmH}_2\text{O}$
M. de uso: 4h9'
 $IAH = 2.8 \text{ e/ev}$
Bem adaptado, porém
- Colchão duro, tem dif. A
iniciar o sono.
* med. - Lipitor.
- suplementos p/ academia
- creatina / Bioteti.
- Zolpidem ou proteína
- Óleo de peixe. *fuca*

18/05
23

$P = 9 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 3.4 \text{ e/ev}$
M. de uso = 4h47'
Bem adaptado. *fuca*

27/06
23

$P = 9 \text{ cmH}_2\text{O}$
M. de uso: 6h32'
 $IAH = 2.0$
Bem adaptado,
relata que o
colchão está ruim. *fuca*

10/10 P = 8 cmH₂O
23 IAH = 4.8 e/ev
m. de uso: 7hs

13/11 P = 9.0 cmH₂O
23 IAH = 4.5 e/ev
m. de uso: 6h12'
Fuga = 18.9 l/min.

Oriento sobre a apneia cen-
tral, lesão no ombro (E)
(usou cataflam.)

fua

15/01 P = 9 cmH₂O
24 Fuga = 14.3 l/min.
IAH = 5.0 e/ev
m. de uso: 5:30hs.

Ana Cláudia

11/03 P = 9.0 cmH₂O
24 IAH = 11.4 cmH₂O
m. de uso: 6h30'
Fuga =

Dormiu barriga p/ cima.

fua

06/05 P = 9.0 cmH₂O
24 IAH = 4.3 e/ev
m. de uso: 6h35'

30d / 100%.

26/06 P = 9.0 cmH₂O
24 IAH = 6.4 e/ev
m. de uso: 7hs
fuga: 5lpm.

23/09 P = 9 cmH₂O
24 IAH = 5.7 e/ev
m. de uso: 7h4'

fua Cláudia

17/12 P = 9 cmH₂O cmH₂O
24 IAH = 4.4 e/ev
m. de uso: 7h05'

30d uso 30d

24/03 P = 9 cmH₂O
25 IAH = 5.9 e/ev
m. de uso: 6h34'
Bem adapt.

A P = 9.6 cmH₂O.

fua

02/09 P = 9.6 cmH₂O
25 IAH = 2.9 e/ev
m. de uso: 6h30'
fuga = 20 e/ev.

- Dormindo bem a noite toda.
- tosse. físico
- Sono reparador.

Nome: RICARDO FRATTINI SANAIOTTE

Data de Nascimento: 3-12-1982

IMC: 36,24

Sexo: Masculino

Data do exame: 26-01-2021

Peso: 111 kg

Altura: 1,75 m

Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE

CARREGOSA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 26-01-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 478,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 22,0 e 117,5 minutos. O tempo total de sono foi de 333,5, eficiência de 69,8% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,4%; estágio N2: 71,7%; estágio N3: 3,6%; sono REM: 22,3%. O índice de despertares foi de 38,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 71,2/hora, sendo elas 75 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 61 hipopnéias. A SpO2 média foi de 88% e mínima de 67%, permanecendo 39,1% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 52 - 87 bpm e NREM de 51 - 83 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (13), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 71,2/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=67%);
5. latências para o sono normais;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

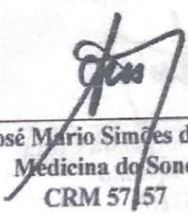
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: RICARDO FRATTINI SANAIOTTE

Data de Nascimento: 3-12-1982

IMC: 36,24

Sexo: Masculino

Data do exame: 27-02-2021

Peso: 111 kg

Altura: 1,75 m

Medico: DR. MARIO SERGIO LEONE

CARREGOSA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia Com Titulação CPAP

Exame realizado na noite de 27-02-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 469,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 33,5 e 76,5 minutos. O tempo total de sono foi de 356,0, eficiência de 75,9% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,1%; estágio N2: 58,0%; estágio N3: 18,5%; sono REM: 20,4%. O índice de despertares foi de 13,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 18,9/hora, sendo elas 35 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 77 hipopnéias. A SpO2 média foi de 90% e mínima de 81%, permanecendo 13,5% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 49 - 92 bpm e NREM de 49 - 81 bpm.

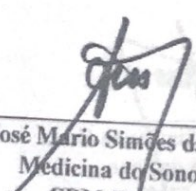
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (12), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM diminuída;
4. aumento do número de despertares breves;
5. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (4,4/hora);
6. registro de ronco leve durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 8 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157